DATO DE ATENCIÓN URGENCIA (DAU)

ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL SAN CARLOS	N°DAU	3741706
CALIDAD	Original	FECHA	14/08/2024 11:12
AREA	U.E. Adulto	BOX	Cama 4
HC	97033404	CTA. CTE.	0

DATOS CONSULTANTE:

Nombre : ROSA ELENA MUÑOZ JELDRES **RUN** : 3.725.655-2 **CP** : 72150
Previsión : FONASA B **F.Nac** : 13/10/1935 **Género** : Femenino **Edad** : 88 Años 10 Meses 1 Días
Dirección : CHACABUCO 189 **Comuna** : SAN CARLOS **Teléfono** : 998644753

DATOS INGRESO:

Procedencia : TERESA BALDECHI (CESFAM) **Mot. Consulta** : MORBILIDAD COMUN
Lug. Ocurrencia : NO_ESPECIFICADO **Med. Llegada** : AMBULANCIA SAPU CESFAM

SELECTOR DEMANDA: 1° llamado: 14/08/2024 11:15:59;

Profesional : LUIS ENRIQUE BASCUÑAN BUSTOS **Hra. Llamada** : 14/08/2024 11:15 **Hora Atención** : 14/08/2024 11:21
T° Axilar : 0 **T° Rectal** : **Presión** : **Pulso** : 94 **Frec. Resp.** : 0
Saturometría : 97 **HGT** : **Peso** : **Glasgow** : **Clasificación** : C3
Motivo de consulta: : ACOMAPAÑADA
DERIVADA CESFAM T. BALDECHI IC MEDICA HIPERPOTASEMIA
pa. 144/70, hgt 84 mg/dl
K: 7.50 TOMADOS 13/08/2024
ALERGIA. NO
am. ASMA, cardioopata, dlp

CONTROL SIGNOS VITALES:

Fecha	Pulso	Presión	T° Axilar	T° Rectal	FR	Sat.	HGT	Profesional
14/08/2024 11:48	95	114/93				96		Nataly San Martín Torres
14/08/2024 12:56	94	134/83	36.2		24	96	91	Virginia Contreras Espinoza
14/08/2024 13:30	90	128/81			28	97		Virginia Contreras Espinoza
14/08/2024 16:31	89	131/82			24	94		Virginia Contreras Espinoza
14/08/2024 17:03	88	132/64			26	96	65	Virginia Contreras Espinoza
14/08/2024 17:34							182	Virginia Contreras Espinoza
14/08/2024 18:34	96	121/79			20	96		Virginia Contreras Espinoza
14/08/2024 19:20	85	121/79	36		22	95	266	Virginia Contreras Espinoza
14/08/2024 19:42							121	Virginia Contreras Espinoza

ACCIDENTE, ALCOHOLEMIA Y/O TOXICOLOGIA:

INFORME LESIONES : NO **INFORME ALCOHOLEMIA:** : NO

ANAMNESIS:

Fecha	Anamnesis	Profesional
14/08/2024 11:36	Mujer, 88 años, con antecedentes de: - HTA - Demencia vascular/senil - Enfermedad de Parkinson - Insuficiencia cardíaca - EPOC/Asma - Dislipidemia - Hernia diafragmática Hospitalización previa en UTI (nov 2022) por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a EPOC exacerbado e ICC descompensada. Requirió VMNI por <24h. En dicha ocasión también cursó con hiperkalemia severa. Hoy derivada desde APS por exámenes alterados: - Creatinina elevada: 1.60 mg/dL - Clearence disminuido: 30.42 mL/min - Hiperkalemia severa: 7.50 mmol/L - Anemia leve: Hb 10.6 g/dL En urgencias: - Ansiosa, con dificultad respiratoria - Signos vitales: PA 128/81, FC 90, FR 28, SatO2 97%, T° 36.2°C - ECG sin alteraciones significativas	Felix Antonio Sanhueza Luna
14/08/2024 14:34	Ingresa por hiperkalemia severa (K+ 7.50 mmol/L) en contexto de infección urinaria. Evoluciona con mejoría parcial tras manejo inicial en urgencias. Se decide egreso con K+ de 6.7 mmol/L para hospitalización domiciliaria, considerando: 1. Patologías de base y estado basal frágil 2. Escaso beneficio adicional de hospitalización convencional vs. domiciliaria	Felix Antonio Sanhueza Luna
14/08/2024 16:57	.	Felix Antonio Sanhueza Luna
14/08/2024 19:45	.	Felix Antonio Sanhueza Luna

EXAMEN FÍSICO :

Fecha	Examen Físico	Profesional

DIAGNÓSTICOS: **Condición de ingreso:** Conciente

Fecha	Hipótesis diagnóstica	Profesional
14/08/2024 14:34	1. Hiperkalemia moderada en resolución 2. ITU baja 3. ERC etapa 3b 4. Comorbilidades ya descritas	Felix Antonio Sanhueza Luna
14/08/2024 16:57	1. Hiperkalemia moderada en resolución 2. ITU baja 3. ERC etapa 3b 4. Comorbilidades ya descritas	Felix Antonio Sanhueza Luna
14/08/2024 19:45	1. Hiperkalemia moderada en resolución 2. ITU baja 3. ERC etapa 3b 4. Comorbilidades ya descritas	Felix Antonio Sanhueza Luna
14/08/2024 19:55	E87.5 HIPERPOTASEMIA.	Felix Antonio Sanhueza Luna

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS (TRATAMIENTO EN BOX):

Fecha	Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos	Profesional	Estado	Responsable
14/08/2024 11:39	SALBUTAMOL 2 PUFF CADA 20 MIN X 3	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 14/08/2024 12:55	Virginia Contreras Espinoza
14/08/2024 11:39	ELECTROCARDIOGRAMA	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 14/08/2024 11:48	VÍCTOR ALEJANDRO LAFUENTE ANDRADES

14/08/2024 11:39	EXS DE LAB	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 14/08/2024 11:48	VÍCTOR ALEJANDRO LAFUENTE ANDRADES
14/08/2024 11:40	RX TORAX	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 14/08/2024 13:09	VÍCTOR ALEJANDRO LAFUENTE ANDRADES
14/08/2024 14:20	gluconato de calcio 1 amp ev	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 14/08/2024 14:39	VÍCTOR ALEJANDRO LAFUENTE ANDRADES
14/08/2024 14:21	sg 30% 3 amp ev + 8 u insulina critalina ev.	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 14/08/2024 14:39	VÍCTOR ALEJANDRO LAFUENTE ANDRADES
14/08/2024 14:21	tras administración de insulina cristalina control de elp	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 14/08/2024 15:53	VÍCTOR ALEJANDRO LAFUENTE ANDRADES
14/08/2024 16:51	sg 30% 3 amp ev + 8 u insulina critalina ev.	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 14/08/2024 17:11	VÍCTOR ALEJANDRO LAFUENTE ANDRADES
14/08/2024 16:52	salbutamol 2 puff cada 15 minutos x 4	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 14/08/2024 17:11	VÍCTOR ALEJANDRO LAFUENTE ANDRADES
14/08/2024 19:51	toma muestra urocultivo (previo egreso a hospi domiciliaria)	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 14/08/2024 21:16	Camila Llanos Morales
14/08/2024 19:51	ceftriaxona 2 g ev	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 14/08/2024 21:16	Camila Llanos Morales

EXAMENES:

Fecha	Examen	Profesional
14/08/2024 11:37	UREMIA ; CREATININEMIA ; E.L.P. ;	Felix Antonio Sanhueza Luna
14/08/2024 14:21	E.L.P. ;	Felix Antonio Sanhueza Luna
14/08/2024 16:54	RCTO GLOBULAR ; GLICEMIA ; UREMIA ; CREATININEMIA ; PERFIL BIOQUIMICO ; E.L.P. ; PCR ; ORINA COMPLETA ; TTPK ; INR ; LDH ; GASES ARTERIALES ; AC. LACTICO ;	Felix Antonio Sanhueza Luna
14/08/2024 20:03	RCTO GLOBULAR ; GLICEMIA ; UREMIA ; CREATININEMIA ; E.L.P. ; PCR ;	Felix Antonio Sanhueza Luna
14/08/2024 11:40	RX T?RAX FRONTAL Y LATERAL	Felix Antonio Sanhueza Luna

INDICACIONES ALTA:

Fecha	Indicación	Profesional
14/08/2024 14:34	- Hospitalización domiciliaria - Ceftriaxona 2 g EV c/24h por 7 días - Suspender espironolactona - Dieta baja en potasio - Hidratación oral 1.5-2 L/día - Control de exámenes en 48h (electrolitos, función renal, rcto globular, pcr) - Control médico en 48h - Mantener tratamiento habitual excepto espironolactona - Furosemida 40 mg 1/2 c/24 h VO por 5 días - Salbutamol 2 puff cada 6 horas - Kayaxelate 15 g c/8h VO por 3 días - Educación a familia sobre signos de alarma	Felix Antonio Sanhueza Luna
14/08/2024 16:57	- Hospitalización domiciliaria - Ceftriaxona 2 g EV c/24h por 7 días - Suspender espironolactona - Dieta baja en potasio - Hidratación oral 1.5-2 L/día - Control de exámenes en 48h (electrolitos, función renal, rcto globular, pcr) - Control médico en 48h - Mantener tratamiento habitual excepto espironolactona - Furosemida 40 mg 1/2 c/24 h VO por 5 días - Salbutamol 2 puff cada 6 horas - Kayaxelate 15 g c/8h VO por 3 días - Educación a familia sobre signos de alarma	Felix Antonio Sanhueza Luna
14/08/2024 19:45	- Hospitalización domiciliaria - Ceftriaxona 2 g EV c/24h por 7 días - Suspender espironolactona - Dieta baja en potasio - Hidratación oral 1.5-2 L/día - Control de exámenes en 48h (electrolitos, función renal, rcto globular, pcr) - Control médico en 48h - Mantener tratamiento habitual excepto espironolactona - Furosemida 40 mg 1/2 c/24 h VO por 5 días - Salbutamol 2 puff cada 6 horas - Kayaxelate 15 g c/8h VO por 3 días - Educación a familia sobre signos de alarma	Felix Antonio Sanhueza Luna

RECETAS:

Fecha	Prescripción	Profesional
14/08/2024 19:56	- Kayaxelate 15 g c/8h VO por 3 días - Ceftriaxona 2 g EV c/24h por 7 días	Felix Antonio Sanhueza Luna

OBSERVACIONES:

Fecha	Indicación	Profesional
14/08/2024 13:10	reg tardio: VVP18 en pbi, ex venosos. Puff salbutamol 2, x 3 veces.	VÍCTOR ALEJANDRO LAFUENTE ANDRADES
14/08/2024 13:14	Rosa Muñoz Jeldres, 88 años, dependiente en AVD (escasa movilizacion). MC: Derivada por hallazgo de Hiperkalemia (7.5). AM: Asma. AQx: Alergias: no refiere. Farmacos: Salbutamol. Ingresa: Vigil, acompañada, desorientada T-E. Yugulares ingurgitadas, piel tibia, rosada. Se observa disneica, 30/min, uso musc accesoria. Adb BDI. EEII. edema +/+.	VÍCTOR ALEJANDRO LAFUENTE ANDRADES
14/08/2024 19:02	HGT: 40mg/dL, se avisa a medico. EV: 2 ampollas G 30%, luego infusión lenta Gluc 10% Luego HGT: 266mg/dL	VÍCTOR ALEJANDRO LAFUENTE ANDRADES
14/08/2024 19:47	cel 9 6538 4495 maria parra	VÍCTOR ALEJANDRO LAFUENTE ANDRADES
14/08/2024 21:17	Tomo muestra de URC por sondeo intermitente sonda nelaton n10 previo aseo genital. Se extraen 40 cc de aprox de orinas concentradas.	Camila Llanos Morales

GES : No **PERTINENCIA** : Si **DESTINO** : Hospital APS

ADVERTENCIA
ESTE ES UN DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO Y SÓLO UNA PRIMERA ATENCIÓN. DEBE CONSULTAR A SU CENTRO DE SALUD O MÉDICO TRATANTE DENTRO DE LAS 12-24 HORAS SIGUIENTES. SI SUS SÍNTOMAS EMPEORAN, CONSULTE NUEVAMENTE A LA BREVEDAD. ES SU RESPONSABILIDAD SEGUIR ESTAS INDICACIONES.

LLAME A SALUD RESPONDE
600•360•7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Felix Antonio Sanhueza Luna
14.542.245-0